

- × 弱い危険因子である
- × 中等度の危険因子である。
- × 弱い危険因子である。
- 高リン脂質抗体症候群などの血栓性素因は強い危険因子である。
- × 中等度の危険因子である。

86 ~ 99

- × 数 % と考えられている。
- 適切な抗凝固療法を 3~6 ヶ月継続しても慢性的に肺高血圧が存在している場合に CTEPH の診断となる。
- 女 3: 男 1 で女性に多い。
- × 70 歳代が発症のピークで、60 歳代がそれに次ぐ。
- 深部静脈血栓やプロテイン C、プロテイン S 欠損などの凝固能異常が背景に存在し、肺に反復して血栓塞栓症を起こすことで生じる。
- 肺野 CT で血流低下域が低吸収域、血流増加部位が高吸収域となりモザイクパターンを呈する例が報告されている。
- × *in situ* での血栓形成機序の関与も考えられており、手術やバルーン肺動脈拡張術などの治療の実施の有無に関わらず、永続的な抗凝固療法が必要である。
- × 手術により肺高血圧が改善すれば右室拡大や壁運動は改善するため、右室機能不全は手術適応除外の要因とはならない。